

# Pancreatitis aguda

---

## 1) Introducción y relevancia clínica

La **pancreatitis aguda (PA)** es una inflamación súbita del páncreas que puede abarcar desde un cuadro **leve autolimitado** hasta una **enfermedad grave con falla orgánica** y necrosis infectada. Es una de las principales causas de hospitalización por patología gastrointestinal. En Chile, la **etiología biliar** (litiasis/coledocolitiasis) y el **alcohol** son responsables de la mayoría de los casos en adultos; fármacos, hipertrigliceridemia, hipercalcemia y causas post-CPRE completan el espectro.

Su importancia clínica radica en tres decisiones **tiempo-dependientes**:

1. **Confirmar el diagnóstico** con criterios estandarizados.
2. **Evaluar gravedad y reanimar** precozmente (fluidoterapia; analgesia; manejo de complicaciones).
3. **Tratar la causa** (p. ej., litiasis biliar: decidir CPRE sí/no y colecistectomía en el mismo ingreso).

El reconocimiento y manejo oportunos **reducen falla orgánica, sepsis y mortalidad**. La clasificación de Atlanta revisada estructura el diagnóstico y la severidad, mientras que guías AGA/WSES/ACG orientan la reanimación, la nutrición y el manejo de la necrosis e infección.

---

## 2) Fisiopatología y bases conceptuales

### 2.1 Cascada fisiopatológica

- **Activación intrapancreática** de enzimas (tripsina) → autodigestión, necrosis de acinos y grasa.
- **Inflamación local** con liberación de citocinas (IL-1, IL-6, TNF- $\alpha$ ).
- **Respuesta inflamatoria sistémica (SIRS)**: vasodilatación, fuga capilar, hipovolemia relativa y riesgo de **falla orgánica** (respiratoria, renal, hemodinámica).
- Evolución bifásica:

- **Fase temprana (1.<sup>a</sup> semana):** SIRS y disfunción orgánica.
- **Fase tardía (≥2.<sup>a</sup>–4.<sup>a</sup> semanas):** complicaciones locales (coleciones, necrosis), con riesgo de **infección**.

## 2.2 Etiología

- **Biliar (litiasis/coledocolitiasis):** aumento de presión ductal, reflujo biliar; relación con colangitis y pancreatitis biliar.
- **Alcohol** (consumo crónico/atracón).
- **Hipertrigliceridemia** (>1000 mg/dL, riesgo exponencial).
- **Fármacos** (p. ej., azatioprina, valproato, tiazidas), **hipercalcemia**, **post-CPRE**, **trauma**, **idiopática**.

## 2.3 Clasificación y definiciones (Atlanta revisada 2012)

- **Diagnóstico de PA:** ≥2 de 3 criterios
    - Dolor abdominal típico (epigástrico, irradiado a dorso).
    - **Amilasa/Lipasa >3×** el límite superior normal.
    - Imágenes compatibles (TAC/RM/ecografía).
  - **Severidad**
    - **Leve:** sin falla orgánica ni complicaciones locales.
    - **Moderadamente grave:** falla orgánica **transitoria (<48 h)** y/o complicación local.
    - **Grave:** **falla orgánica persistente (>48 h)**, con alta mortalidad.
  - **Morfología**
    - **Intersticial edematosa** vs **necrosante** (pancreática y/o peripancreática).
    - **Coleciones:** aguda peripancreática/necrosis aguda (≤4 sem) → **pseudocisto/walled-off necrosis (WON)** (≥4 sem).
-

### 3) Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

#### 3.1 Manifestaciones clínicas

- **Dolor epigástrico intenso**, continuo, **en cinturón** a dorso; alivia en **anteflexión**.
- **Náuseas y vómitos** frecuentes.
- **Ileo** (distensión, ruidos disminuidos).
- **Fiebre** y taquicardia en cuadros moderados-graves.
- Signos de alarma: **hipotensión, oliguria, Taquipnea/hipoxemia** (SDRA).

#### 3.2 Examen físico

- Dolor epigástrico con defensa variable.
- Ictericia en pancreatitis **biliar** (si colestasis).
- Signos raros: **Cullen/Grey-Turner** (hemorragia retroperitoneal).

#### 3.3 Diagnóstico diferencial

- **Colecistitis, úlcera péptica perforada, isquemia mesentérica, obstrucción intestinal, IAM inferior, aneurisma aórtico, cólico renal y hepatitis aguda.**
- 

### 4) Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

#### 4.1 Laboratorio

- **Lipasa** (preferente) y amilasa:  $>3\times$  LSN confirman (si clínica típica).
- **Hemograma** (leucocitosis), **PCR** (severidad), **lactato** (hipoperfusión).
- **Perfil hepático**: BT, FA, GGT, **TGO/TGP** ( $\uparrow$  apoyan etiología biliar).
- **Calcio, triglicéridos, glicemia, creatinina.**
- **Gasometría** si hipoxemia.

## 4.2 Imágenes

- **Ecografía abdominal: examen inicial** para buscar **litiasis vesicular** y colédoco dilatado; puede ver líquido peripancreático.
- **TAC con contraste** (no de rutina al ingreso): indicada si **diagnóstico incierto, deterioro clínico, sospecha de complicación** o para planificar intervenciones; ideal tras 72 h si se busca necrosis.
- **RM/colangiografía resonancia**: alternativas sin radiación; útil en coledocolitiasis cuando la ecografía es inconcluyente.

## 4.3 Estratificación de gravedad

- **Clínica**: SIRS (FR, FC, T°, leucocitos) y perfusión.
  - **Scores**: **BISAP** ( $\geq 3$  = riesgo), **qSOFA/SOFA** (falla orgánica).
  - **Imágenes**: Índice de severidad por **TAC (Balthazar mod.)** y % de necrosis (correlación con morbi-mortalidad).
- 

# 5) Tratamiento (según guías AGA/ACG/WSES y práctica clínica)

## 5.1 Principios

1. **Soporte hemodinámico y analgesia** inmediatos.
2. **Nutrición enteral precoz** preferida a NPT.
3. **Biliar**: decidir **CPRE** (solo si **colangitis** o obstrucción en curso) y realizar **colecistectomía durante el mismo ingreso** para prevenir recurrencias.

## 5.2 Fluidoterapia (reanimación)

- Iniciar **temprano (primeras 12–24 h)** con **cristaloides** guiados por metas (FC, PAM, diuresis  $\geq 0,5$  mL/kg/h, lactato).
- Preferir **Ringer Lactato (RL)** sobre suero fisiológico para reducir **acidosis hiperclorémica** y posiblemente SIRS/IRA.

- Ritmo inicial **5–10 mL/kg/h** en cuadros moderados-graves, titulando según respuesta; evitar sobrecarga (edema pulmonar, compartimental abdominal).

**Perla:** la fluidoterapia “agresiva ciega” se asocia a peor evolución; la pauta actual es **hidratación juiciosa y dirigida por objetivos**.

### 5.3 Analgesia y soporte

- **Paracetamol/AINEs + opioides** (p. ej. morfina/fentanilo) según dolor.
- Oxigenoterapia para  $\text{SatO}_2 >94\%$ ; cuidados de UCI si falla orgánica.

### 5.4 Nutrición

- **VO/enteral precoz ( $\leq 24$  h)** si el dolor y el vómito lo permiten; dieta **baja en grasa** y progresiva.
- Si no tolera VO, **nutrición enteral por sonda** (NG o NJ) es preferida a NPT ( $\downarrow$  infecciones y mortalidad).

### 5.5 Antibióticos

- **No profilácticos** en pancreatitis necrosante **estéril**.
- **Indicar** solo si hay **infección** documentada o alta sospecha (gas en necrosis, deterioro séptico, PAAF positiva) y/o **colangitis**.
- En **necrosis infectada**, iniciar antibióticos de **buena penetración tisular** (p. ej. carbapenémicos) mientras se planifica el **drenaje/step-up**.

### 5.6 CPRE y vía biliar

- **Urgente ( $<24$  h)** si **colangitis** o **obstrucción biliar persistente** (ictericia con colédoco dilatado y colestasis marcada).
- **No** se recomienda CPRE de rutina en pancreatitis biliar **sin colangitis**.

### 5.7 Colecistectomía

- En **pancreatitis biliar leve-moderada**, realizar **colecistectomía laparoscópica en el mismo ingreso** (idealmente antes del alta) para prevenir recurrencias y rehospitalizaciones tempranas.

## 5.8 Complicaciones locales y manejo “step-up”

- **WON/necrosis infectada:** si el paciente se deteriora o persiste séptico, seguir estrategia **escalonada**:
    1. **Antibióticos + drenaje percutáneo/endoscópico** guiado por imagen.
    2. **Necrosectomía mínimamente invasiva** (endoscópica o retroperitoneal) si fracaso del drenaje.
    3. **Cirugía abierta** como último paso.
  - **Diferir intervención** idealmente **≥4 semanas** hasta que la colección se **organice** (WON), lo que **reduce morbilidad**.
- 

## 6) Complicaciones y pronóstico

### 6.1 Complicaciones locales

- **Colecciones agudas** peripancreáticas, **pseudocisto**, **necrosis** (pancreática/peripancreática), **WON**.
- **Infección** de la necrosis (pico 2.<sup>a</sup>–4.<sup>a</sup> semana).
- **Hemorragia** por erosión vascular; **fístulas** (pancreatopleural, entéricas).
- **Obstrucción** biliar o duodenal por masas inflamatorias.

### 6.2 Complicaciones sistémicas

- **SDRA**, **IRA**, **shock séptico**, coagulopatía, hipocalcemia sintomática.
- Desnutrición proteico-calórica en formas graves.

### 6.3 Pronóstico

- **Leve:** resolución en 3–7 días, baja mortalidad.
- **Grave** (falla orgánica persistente): mortalidad significativa, incrementada si **necrosis infectada**.

- Factores de mal pronóstico: edad avanzada, obesidad, comorbilidades, **BISAP ≥3**, hematocrito y BUN elevados en admisión, lactato alto, persistencia de SIRS.
- 

## 7) Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

### □ Perlas

1. **Diagnóstico clínico-bioquímico**: basta con **2 de 3** (dolor típico, enzimas >3×, imagen) — no esperes TAC si la clínica es clara y el paciente mejora.
2. **Reanimación dirigida** con **Ringer Lactato** es preferible a SSF, evitando sobrecarga; reevalúa con diuresis, PAM y lactato.
3. **Alimentación precoz** (≤24 h) reduce infecciones y estancia; si no tolera VO, usa **enteral** (NG/NJ) en vez de NPT.
4. **CPRE** solo si **colangitis** o **obstrucción**; no de rutina en pancreatitis biliar no complicada.
5. **Antibióticos**: nunca profilaxis; sí ante **necrosis infectada** o colangitis, y mientras planificas **drenaje/step-up**.
6. **Colecistectomía en el mismo ingreso** en etiología biliar leve-moderada previene recidivas tempranas.
7. Diferir necrosectomía **≈4 semanas** si es posible (WON): menos complicaciones que la cirugía temprana.

### □ Errores comunes

- “Cargar” suero fisiológico en exceso sin metas → acidosis hiperclorémica/edema.
- Mantener **ayuno prolongado** sin intentar VO/enteral temprana.
- Solicitar **CPRE sin criterios** (aumenta riesgo de complicaciones).
- Usar **antibióticos profilácticos** en necrosis estéril.
- Indicar **TAC al ingreso** en cuadros claros y estables.
- Dar de alta pancreatitis biliar **sin colecistectomía planificada** (alta tasa de recidiva).

---

## 8) Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Diagnóstico** de PA con **2/3**: dolor típico, **lipasa/amilasa >3x**, imagen; clasifica severidad según **Atlanta** (leve, moderada, grave).
2. **Fluidoterapia precoz y dirigida** (ideal **Ringer Lactato**, 5–10 mL/kg/h ajustado a metas) + **analgesia** adecuada.
3. **Nutrición**: VO/enteral **dentro de 24 h**; si no tolera, **enteral** antes que NPT.
4. **Biliar**: **CPRE urgente** solo ante **colangitis/obstrucción**; **colecistectomía** en **mismo ingreso** en cuadros leves-moderados.
5. **No antibióticos de rutina**; úsalos si **necrosis infectada** o **colangitis** y planifica **drenaje/step-up** diferido ( $\geq 4$  sem) cuando sea posible.
6. **TAC con contraste** se reserva para dudas diagnósticas, mala evolución o planificación de intervención (ideal tras 72 h si buscas necrosis).
7. La **mortalidad** se asocia a **falla orgánica persistente**; monitoriza SIRS, BISAP, BUN/creatinina y lactato para estratificar y decidir UCI.